

SANTÉ PUBLIQUE

Fiches QE Haute Fréquence – Version 1

Cross-match : 541 QEs officielles (2017→2025) × Cours AIO Santé Publique 2025-2026
Pr Amine, Pr Sebbani, Pr Adermouch – FMPM 2026

PARTIE 1 – CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 541 QEs (11 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Études étiologiques (cas-témoins + cohorte)	93 Q	Pr. Amine
2	Études descriptives	60 Q	Pr. Amine
3	Promotion et prévention en Santé Publique	57 Q	Pr. Sebbani
4	Concepts en santé publique (partie 1 et 2)	57 Q	Pr. Adermouch
5	Déterminants de la santé	51 Q	Pr. Adermouch
6	Sécurité et qualité de soins	46 Q	Pr. Sebbani
7	Santé environnementale	42 Q	Pr. Adermouch
8	Intervention en Santé Publique	32 Q	Pr. Sebbani
9	Essai clinique randomisé	28 Q	Pr. Amine
10	Santé et maladie	23 Q	Pr. Adermouch
11	Mesure de fréquence en épidémiologie	5 Q	Pr. Amine
12	Initiation à la méthodologie de recherche clinique	– (pas de QE)	Pr. Amine
13	Critères de causalité	– (pas de QE)	Pr. Amine
14	Validité d'un test diagnostic	– (pas de QE)	Pr. Amine
15	Planification d'une intervention en SP	– (pas de QE)	Pr. Sebbani
16	Caractériser l'exposition environnementale	– (pas de QE)	Pr. Adermouch
17	Intervention environnementale	– (pas de QE)	Pr. Adermouch

PARTIE 2 – MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 11 sessions, chaque examen ~49.2 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'examen
Études étiologiques (cas-témoins + cohorte)	93	8.45	17.2%
Études descriptives	60	5.45	11.1%
Promotion et prévention en SP	57	5.18	10.5%
Concepts en santé publique (partie 1 et 2)	57	5.18	10.5%
Déterminants de la santé	51	4.64	9.4%
Sécurité et qualité de soins	46	4.18	8.5%
Santé environnementale	42	3.82	7.8%
Intervention en Santé Publique	32	2.91	5.9%
Essai clinique randomisé	28	2.55	5.2%
Santé et maladie	23	2.09	4.2%
Mesure de fréquence en épidémiologie	5	0.45	0.9%
Leçons sans QE historique (6 leçons)	0	0	–
TOTAL leçons officielles avec QE	494 Q	44.9	91.3%

PARTIE 3 – QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (▲) / source (📖) / lien cours (🔗) / citations (📌)

[RANG 1] ÉTUDES ÉTIOLOGIQUES (CAS-TÉMOINS + COHORTE)

Pr. Amine • ~8.45 Q/examen (17.2% de l'examen)

📖 Méthodologie de recherche clinique – études analytiques observationnelles

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 🔗

Les études étiologiques incluent :

- Étude cas-témoins (observationnelle, rétrospective)
- Étude de cohorte (observationnelle, prospective ou rétrospective)
- ▲ L'essai clinique randomisé est INTERVENTIONNEL, PAS étiologique observationnel
- ▲ L'étude transversale est DESCRIPTIVE, pas étiologique

L'étude cas-témoins – caractéristiques :

- Compare un groupe « cas » (malades) à un groupe « témoins » (non malades)
- Recherche rétrospective de l'exposition antérieure
- Calcule l'ODDS RATIO (OR) – PAS le risque relatif, PAS l'incidence
- Adaptée aux maladies rares et à longue période de latence
- Rapide, peu coûteuse
- ▲ Sujette aux BIAIS D'INFORMATION (biais de mémoire +++)
- ▲ NE permet PAS de calculer l'incidence ni la prévalence ni le risque relatif
- ▲ NE prouve PAS la causalité (séquence temporelle ambiguë)
- ▲ NON randomisée (pas d'essai clinique sur cas-témoins)

L'étude de cohorte – caractéristiques :

- Compare un groupe exposé à un groupe non exposé
- Suivi prospectif de l'apparition de la maladie
- Calcule l'INCIDENCE + le RISQUE RELATIF (RR)
- Établit la RELATION TEMPORELLE exposition → maladie (preuve de chronologie)
- Adaptée aux expositions fréquentes
- ▲ Long suivi nécessaire → coût élevé, perdus de vue
- ▲ Inadaptée aux maladies rares (nécessite gros échantillon)
- ▲ NE permet PAS le calcul de la prévalence (= étude transversale)
- ▲ Coût ÉLEVÉ (pas « coût faible »)

Interprétation de l'intervalle de confiance (IC 95%) :

- Association significative si IC NE CONTIENT PAS 1 (pour OR ou RR)
- Si IC = [0.4 ; 6.2] et contient 1 → ASSOCIATION NON SIGNIFICATIVE
- RR > 1 ou OR > 1 → facteur de RISQUE
- RR < 1 ou OR < 1 → facteur PROTECTEUR (si significatif)
- ▲ Le seuil de signification est 1 (PAS 0) pour OR/RR
- ▲ Le seuil 0 s'applique aux différences (différence de moyennes, de pourcentages)

Cohorte prospective vs rétrospective :

- Prospective : exposition mesurée AVANT la survenue de la maladie
- Rétrospective (historique) : exposition recherchée dans des dossiers antérieurs
- Les deux types sont des études étiologiques observationnelles longitudinales
- ⚠ Une cohorte rétrospective ≠ étude cas-témoins (la cohorte part de l'exposition)

[RANG 2] ÉTUDES DESCRIPTIVES

Pr. Amine • ~5.45 Q/examen (11.1% de l'examen)

📖 Méthodologie de recherche clinique – études descriptives

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Types d'études descriptives :

- Étude transversale (= prévalence à un instant donné)
- Étude de série de cas
- Étude écologique (population)
- Étude longitudinale descriptive (sans groupe de comparaison)
- ⚠ L'étude cas-témoins est ANALYTIQUE, pas descriptive
- ⚠ L'essai clinique est INTERVENTIONNEL, pas descriptif

L'étude transversale – but et résultat principal :

- Mesure la PRÉVALENCE (cas existants à un instant donné)
- Estime l'ampleur d'un problème de santé dans une population
- Génératrice d'hypothèses (PAS de test d'hypothèse causale)
- Rapide, peu coûteuse
- ⚠ NE permet PAS de mesurer l'incidence (= apparition de nouveaux cas, nécessite suivi)
- ⚠ NE permet PAS d'établir une séquence temporelle exposition-maladie
- ⚠ NE permet PAS de calculer un risque relatif

Types d'échantillonnage :

- Échantillon probabiliste (aléatoire simple, systématique, stratifié, en grappes)
- Sondage systématique : probabilité égale pour chaque unité d'être tirée
- Échantillon non probabiliste (accidentel, par convenance, en boule de neige)
- ⚠ Un échantillon « accidentel » est NON probabiliste
- ⚠ Inférence statistique impossible avec un échantillon non probabiliste

Types de variables et de questions :

- Variables quantitatives (continues / discrètes)
- Variables qualitatives (nominales / ordinales)
- Questions FERMÉES : rapides à remplir, simples à coder, limitent la liberté d'expression
- Questions OUVERTES : laissent libre expression, mais difficiles à coder

- ▲ Les questions fermées NE SONT PAS difficiles à interpréter (au contraire, simples à coder)
- ▲ Le poids est une variable QUANTITATIVE CONTINUE (correspond à une question fermée numérique)

[RANG 3] PROMOTION ET PRÉVENTION EN SANTÉ PUBLIQUE

Pr. Sebbani • ~5.18 Q/examen (10.5% de l'examen)

📖 Charte d'Ottawa OMS 1986 – Promotion de la santé

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Promotion vs Prévention – différences fondamentales :

- Promotion = modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL, agit sur les DÉTERMINANTS de la santé
- Promotion considère la population comme SUJET (acteur, pas objet)
- Prévention = action sur les facteurs de risque d'une maladie spécifique
- Prévention considère plus souvent la population comme OBJET
- ▲ La promotion N'EST PAS basée sur la responsabilité individuelle (= prévention)
- ▲ La promotion N'ADOpte PAS une approche verticale par programmes
- ▲ Ne pas confondre EPS (éducation pour la santé) avec promotion globale

Les niveaux de prévention :

- Prévention PRIMAIRE : empêcher l'apparition de la maladie (vaccination, hygiène, éducation)
- Prévention SECONDAIRE : dépistage précoce + traitement précoce (frottis, mammographie)
- Prévention TERTIAIRE : limiter complications et séquelles, réadaptation
- Certains auteurs : prévention QUATERNAIRE (éviter le surmédicalisation iatrogène)
- ▲ Le dépistage est de la prévention SECONDAIRE (pas primaire)
- ▲ La rééducation post-AVC est TERTIAIRE (pas secondaire)

Les 5 axes de la Charte d'Ottawa (OMS 1986) :

- Élaborer des politiques publiques saines
- Créer des milieux favorables à la santé
- Renforcer l'action communautaire
- Acquérir des aptitudes individuelles (éducation pour la santé)
- Réorienter les services de santé
- ▲ La sensibilisation individuelle SEULE ne couvre que « aptitudes individuelles » (PAS les 4 autres axes)

Prévention de l'HTA (mesures non médicamenteuses) :

- Réduction de l'apport sodé (idéal < 5-6 g/j)
- Activité physique aérobie régulière (≥ 150 min/semaine)
- Régime DASH (riche en fruits, légumes, faible en graisses saturées)
- Observance des recommandations thérapeutiques
- Arrêt du tabac, réduction de l'alcool, perte de poids

- ⚠ Le régime hyperprotidique N'EST PAS recommandé dans l'HTA
- ⚠ Réduction du sodium à 7 g/j est INSUFFISANTE (cible < 5 g/j idéalement)

Modèle de soins de Wagner pour les maladies chroniques (CCM) :

- Soins INTÉGRÉS, GLOBAUX et CONTINUS centrés sur le patient
- Soins PRIMAIRES coordonnés
- Implique : patient activé + équipe préparée + système organisé
- Particulièrement adapté aux troubles mentaux et maladies chroniques
- ⚠ Le modèle Wagner N'EST PAS basé sur les soins d'urgence ni les soins tertiaires
- ⚠ Soins continus ≠ soins épisodiques

[RANG 4] CONCEPTS EN SANTÉ PUBLIQUE

Pr. Adermouch • ~5.18 Q/examen (10.5% de l'examen)

📖 Classification Internationale du Fonctionnement (CIF) – OMS

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Triade CIF (OMS) : déficience / incapacité / handicap :

- DÉFICIENCE = anomalie de la structure anatomique ou de la fonction organique
- INCAPACITÉ = diminution de la possibilité de réaliser une ACTIVITÉ
- HANDICAP (désavantage social) = désavantage qui limite l'accomplissement d'un RÔLE social
- ⚠ Déficience ≠ incapacité ≠ handicap (PIÈGE CLASSIQUE répété chaque année)
- ⚠ L'incapacité N'EST PAS une anomalie anatomique (= déficience)
- ⚠ L'incapacité N'EST PAS un désavantage social (= handicap)
- ⚠ L'incapacité N'EST PAS une manifestation de la phase pré-clinique

Modèles de définition de la santé :

- Modèle BIOMÉDICAL : santé = absence de maladie
- Modèle ÉCOLOGIQUE / capacité d'adaptation : santé = capacité d'adaptation à l'environnement (OMS révisée)
- Modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL : intègre dimensions physiques, mentales, sociales
- Modèle HOLISTIQUE : approche globale incluant spirituel
- ⚠ Capacité d'adaptation = modèle ÉCOLOGIQUE (PAS holistique, PAS bio-psycho-social)
- ⚠ Le modèle biomédical EST RÉDUCTEUR (centré sur la maladie)

Caractéristiques fondamentales de la santé publique :

- Rôle MAJEUR de la PRÉVENTION (≠ médecine curative)
- Responsabilité COLLECTIVE face à la santé
- Action ciblant la POPULATION (PAS l'individu)
- Action sur les DÉTERMINANTS de la santé
- ⚠ La SP n'est PAS basée sur la médecine curative individuelle
- ⚠ Différence claire avec la médecine clinique (individu vs population)

Phases du processus de développement de la maladie :

- Phase d'exposition aux facteurs de risque
- Phase pré-clinique (subclinique, asymptomatique) – dépistage possible
- Phase clinique (manifestation des symptômes)
- Phase de résolution / chronicité / complications
- ▲ *L'incapacité survient APRÈS la phase clinique (résultat de la maladie)*
- ▲ *Le dépistage cible la phase PRÉ-CLINIQUE*

[RANG 5] DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Pr. Adermouch • ~4.64 Q/examen (9.4% de l'examen)

📖 Modèles de Lalonde, Dahlgren-Whitehead, OMS – déterminants sociaux de la santé

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Les grandes catégories de déterminants de la santé :

- Déterminants BIOLOGIQUES : âge, sexe, génétique, hérédité
- Déterminants COMPORTEMENTAUX : tabac, alcool, alimentation, sédentarité, sexualité
- Déterminants SOCIAUX : niveau d'éducation, revenu, profession, conditions de vie
- Déterminants ENVIRONNEMENTAUX : qualité air/eau/sol, habitat, milieu de travail
- Déterminants liés au SYSTÈME DE SANTÉ : accès, qualité, couverture
- ▲ *L'âge est un déterminant BIOLOGIQUE (PAS comportemental ni social)*
- ▲ *Le tabagisme est COMPORTEMENTAL (PAS biologique)*
- ▲ *La pauvreté est un déterminant SOCIAL (PAS biologique)*

Le système de soins marocain – caractéristiques :

- Budget annuel alloué à la santé par l'État (mais part FAIBLE dans le budget total)
- Contribution DIRECTE des ménages importante (out-of-pocket élevé)
- Assurance maladie ne couvre PAS la totalité de la population (taux en progression)
- Système mixte : public, privé, traditionnel
- ▲ *L'assurance maladie NE COUVRE PAS la totalité de la population au Maroc*
- ▲ *La part du budget santé est FAIBLE (souvent < 6% du budget total)*
- ▲ *La contribution directe des ménages est IMPORTANTE (signe de barrière financière)*

Approches d'intervention en santé publique :

- Approche BIOMÉDICALE : centrée sur la maladie, individuelle (= médecin clinicien)
- Approche BIO-PSYCHO-SOCIALE : intègre les dimensions sociales et psychologiques
- Approche GLOBALE / holistique
- Approche PRÉVENTIVE : agit avant la maladie
- Approche PROMOTIONNELLE : agit sur les déterminants

- ▲ L'intervention du médecin traitant est principalement BIOMÉDICALE + PRÉVENTIVE
- ▲ Une consultation de sevrage tabagique est PRÉVENTIVE (PAS promotionnelle au sens large)

[RANG 6] SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE SOINS

Pr. Sebbani • ~4.18 Q/examen (8.5% de l'examen)

▮ Définitions OMS – Sécurité du patient & dimensions de la qualité des soins

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Définitions clés en sécurité des soins :

- ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE (EI) = situation DÉFAVORABLE au patient
- ERREUR MÉDICALE = EI ÉVITABLE (caractère évitable identifié)
- EI ASSOCIÉ AUX SOINS (EIAS) = EI lié aux activités de soins
- Presque accident (near miss) = événement évité de justesse
- ▲ Un retard d'intervention chirurgicale par perte de bilan = EI + erreur médicale + EIAS
- ▲ Le résultat lié à l'évolution NATURELLE de la maladie n'est PAS un EI
- ▲ Tout EI n'est PAS forcément une erreur médicale (≠ caractère évitable)

Les 6-7 dimensions de la qualité des soins (IOM / OMS) :

- EFFICACITÉ : capacité à atteindre le résultat thérapeutique attendu
- EFFICIENCE : rapport qualité-prix, optimisation des ressources
- SÉCURITÉ : minimiser les risques pour le patient
- ACCEPTABILITÉ / centrage patient
- ACCESSIBILITÉ : géographique, financière, culturelle
- ÉQUITÉ : même qualité pour tous
- CONTINUITÉ : suivi cohérent dans le temps
- ▲ Efficacité ≠ efficience (efficience inclut le COÛT)
- ▲ L'efficience inclut le rapport qualité-prix (« délivrer des soins optimaux au moindre coût »)
- ▲ Efficacité = atteindre le résultat ; efficience = l'atteindre avec un coût optimal

Méthodes d'amélioration de la qualité et analyse des EI :

- AUDIT CLINIQUE (interne ou externe) : comparaison à un référentiel
- REVUE DE MORBIDITÉ-MORTALITÉ (RMM) : analyse rétrospective des EI graves
- PATIENT TRACEUR : suit le parcours d'un patient pour évaluer les pratiques
- ENQUÊTE DE SATISFACTION : perception patient
- MÉTHODE DES 5 POURQUOI : analyse de cause racine
- RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES + ALARM
- CERTIFICATION / accréditation des établissements
- ▲ Pour un EI à incidence élevée (fièvre post-injection) → RMM est l'approche la plus appropriée
- ▲ Un signalement à l'équipe + analyse + formation = recommandations communes (PAS sanction)

- **▲ Le simple constat n'est PAS une méthode d'amélioration de la qualité**

Évaluation d'un programme de santé :

- Évaluation NORMATIVE : conformité aux normes / atteinte des objectifs opérationnels
- Évaluation PRAGMATIQUE : conformité du processus (souvent en cours de programme)
- Évaluation de RECHERCHE : études pharmaco-épidémiologiques, RCT
- Évaluation peut être faite À DIFFÉRENTS MOMENTS (avant, pendant, après)
- **▲ L'évaluation N'EST PAS uniquement faite en fin de programme**
- **▲ L'efficacité THÉORIQUE intermédiaire n'est pas un standard reconnu (on parle d'efficacité réelle)**

Transmission des agents infectieux :

- Transmission DIRECTE : contact physique direct (toucher, gouttelettes proches)
- Transmission INDIRECTE : via vecteur, support contaminé, aérosols, fluides
- Exemples directs : grippe (gouttelettes), tuberculose (aérosols)
- Exemples indirects : hépatite A (eau/aliments), tétanos (sol), paludisme (moustique)
- **▲ Le tétanos est INDIRECT (par contamination tellurique)**
- **▲ Le paludisme est INDIRECT (vecteur = moustique)**
- **▲ L'hépatite A est INDIRECTE (féco-orale via eau/aliments)**

[RANG 7] SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Pr. Adermouch • ~3.82 Q/examen (7.8% de l'examen)

▣ Modèle DPSEEA (OMS) – Driving forces, Pressures, States, Exposures, Effects, Actions

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Types d'agents environnementaux :

- Agents PHYSIQUES : radiations ionisantes/UV, bruit, chaleur, vibrations
- Agents CHIMIQUES : polluants atmosphériques, pesticides, métaux lourds, aérosols industriels
- Agents BIOLOGIQUES : bactéries, virus, champignons, allergènes
- Agents VIVANTS : vecteurs (moustiques, tiques), faune nuisible
- **▲ Les radiations (accident nucléaire) sont des agents PHYSIQUES (PAS chimiques)**
- **▲ Les aérosols industriels sont CHIMIQUES (PAS physiques ni biologiques)**
- **▲ Un moustique vecteur est un agent VIVANT (PAS biologique au sens strict)**

Vecteurs / milieux d'exposition :

- AIR (inhalation de polluants, aérosols, particules fines)
- EAU (ingestion d'eau contaminée – bactéries, métaux lourds)
- SOL (contact cutané, ingestion de poussières)
- ALIMENTS (ingestion d'aliments contaminés ou avec résidus de pesticides)

- ▲ *Un seul agent peut emprunter plusieurs vecteurs (ex. plomb : air + eau + aliments)*
- ▲ *L'identification du vecteur conditionne la stratégie de prévention*

Modèles temporels d'exposition :

- CONTINUE : exposition permanente (ex. tabagisme régulier)
- INTERMITTENTE : exposition répétée à intervalles (ex. exposition professionnelle)
- CONCENTRÉE : exposition brève mais à forte dose (ex. accident industriel)
- ALÉATOIRE (random) : exposition imprévisible
- ▲ *Une exposition CONCENTRÉE = courte durée + forte dose (pas une exposition étalée)*
- ▲ *Une exposition continue n'est pas forcément intermittente*

Voies d'exposition (pénétration dans l'organisme) :

- INHALATION (voie respiratoire) – la plus fréquente pour les polluants atmosphériques
- INGESTION (voie digestive) – eau/aliments contaminés
- ABSORPTION CUTANÉE – pesticides, solvants
- Voie transplacentaire (effet sur le fœtus)
- ▲ *Inhalation = voie respiratoire (PAS digestive)*
- ▲ *Pour un polluant dans l'air → la voie principale est l'inhalation (pas l'ingestion)*

Types d'effets sur la santé :

- Effet AIGU : apparition rapide après l'exposition (ex. syndrome d'irradiation aiguë)
- Effet CHRONIQUE : apparition après exposition prolongée
- Effet RETARDÉ : apparition années après l'exposition (ex. cancer de la thyroïde post-irradiation)
- Effet INFRACLINIQUE : modifications biologiques sans symptômes
- ▲ *L'irradiation aiguë + cancer thyroïdien tardif illustrent les effets AIGU + RETARDÉ (PAS chronique)*
- ▲ *Un effet « positif » n'a pas de sens en toxicologie environnementale*

[RANG 8] INTERVENTION EN SANTÉ PUBLIQUE

Pr. Sebbani • ~2.91 Q/examen (5.9% de l'examen)

📖 Critères SMART + Principes de l'offre de soins au Maroc

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Les 5 composantes d'une intervention en santé publique :

- Les ACTEURS (qui intervient)
- Les STRUCTURES (où l'intervention a lieu)
- Le PROCESSUS (comment elle se déroule)
- Les MOYENS (ressources mobilisées)
- Les RÉSULTATS (objectifs atteints)

- L'ENVIRONNEMENT (contexte de l'intervention)
- La FINALITÉ (but général visé)
- ⚠ *Une intervention sans description du PROCESSUS ou des MOYENS est incomplète*

Type d'intervention (niveau et population cible) :

- Intervention PRÉCLINIQUE : avant l'apparition de symptômes (vaccination, hygiène)
- Intervention CLINIQUE : sur patient symptomatique (consultation, prescription)
- Intervention POST-CLINIQUE : rééducation, réadaptation
- Intervention INDIVIDUELLE : ciblée sur une personne
- Intervention POPULATIONNELLE : ciblée sur un groupe
- ⚠ *Une consultation avec prescription = intervention CLINIQUE + INDIVIDUELLE*

Critères SMART pour un objectif d'intervention :

- S = Spécifique (précis)
- M = Mesurable
- A = Atteignable
- R = Réaliste
- T = Temps défini
- ⚠ *Un objectif SMART doit être PRÉCIS + MESURABLE + TEMPS DÉFINI minimum*
- ⚠ *« Sensible » n'est PAS un critère SMART (piège classique)*

Critères d'inclusion d'une intervention de dépistage (OMS Wilson-Jungner) :

- Maladie GRAVE = problème de santé publique important
- Histoire naturelle de la maladie CONNUE
- Test de dépistage FIABLE, EFFICACE, ACCEPTABLE, peu coûteux
- Traitement disponible à un stade précoce
- Coût du programme acceptable
- Proportion importante de la population concernée
- ⚠ *L'ABSENCE de test fiable est un CONTRE-ARGUMENT (pas un argument de dépistage)*
- ⚠ *Un coût FAIBLE de PEC est un argument (un coût élevé est un frein, pas un argument)*

Principes de l'offre de soins au Maroc :

- ÉGALITÉ : même droit aux soins pour tous les citoyens
- ÉQUITÉ : adaptation aux besoins spécifiques
- SOLIDARITÉ : entraide collective (assurance maladie)
- GRADATION : organisation par niveaux (primaire → secondaire → tertiaire)
- COMPLÉMENTARITÉ : entre niveaux et secteurs
- PARTENARIAT public-privé
- INTERSECTORIALITÉ : action de plusieurs secteurs (santé, éducation, social)
- ⚠ *Quand un patient saute le centre de santé pour aller directement au CHU → défaut de GRADATION*
- ⚠ *L'action concertée DRS + CHU illustre COMPLÉMENTARITÉ + INTERSECTORIALITÉ*

[RANG 9] ESSAI CLINIQUE RANDOMISÉ (ECR)

Pr. Amine • ~2.55 Q/examen (5.2% de l'examen)

📖 Méthodologie de recherche clinique – niveau de preuve le plus élevé (étude expérimentale)

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Définition et caractéristiques de l'ECR :

- Étude INTERVENTIONNELLE (≠ observationnelle)
- Étude LONGITUDINALE et PROSPECTIVE (suivi des patients)
- Comparaison entre ≥ 2 groupes (traitement vs placebo, ou nouveau vs standard)
- Niveau de preuve LE PLUS ÉLEVÉ pour évaluer l'efficacité d'un traitement
- ⚠ L'ECR N'EST PAS une étude observationnelle
- ⚠ L'ECR N'EST PAS rétrospective

La randomisation :

- RÉPARTITION ALÉATOIRE (tirage au sort) des sujets en 2 groupes ou plus
- Basée sur le HASARD (pas sur choix du chercheur ni faisabilité)
- Permet de constituer des groupes COMPARABLES sur les caractéristiques connues ET INCONNUES
- Permet de contrôler les facteurs de confusion CONNUS ET INCONNUS
- Rend possible l'inférence statistique causale
- ⚠ La randomisation NE PEUT PAS être réalisée dans une étude cas-témoins (observationnelle)
- ⚠ La randomisation N'EST PAS basée sur les contraintes du terrain
- ⚠ Elle NE constitue PAS deux groupes IDENTIQUES (mais COMPARABLES)

Insu (aveugle) :

- Simple aveugle : le patient ignore son groupe
- Double aveugle : patient + investigateur ignorent
- Triple aveugle : + statisticien aussi
- Réduit le BIAIS DE MESURE et le biais d'évaluation
- ⚠ L'insu réduit les biais d'INFORMATION (PAS de sélection)
- ⚠ L'insu n'est pas toujours possible (chirurgie, thérapies comportementales)

Sondage systématique :

- Probabilité égale pour chaque unité statistique d'être tirée au sort
- Méthode probabiliste d'échantillonnage
- Tirage d'une unité tous les « k » éléments ($k = N/n$)
- ⚠ Si on tire « toutes les k unités » à partir d'un point aléatoire → PROBABILITÉ ÉGALE (VRAI)

[RANG 10] SANTÉ ET MALADIE

Pr. Adermouch • ~2.09 Q/examen (4.2% de l'examen)

📖 Théorie de la transition épidémiologique (Omran 1971)

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

La transition épidémiologique :

- DIMINUTION des maladies infectieuses + AUGMENTATION des maladies chroniques (non transmissibles)
- Causée par : urbanisation, allongement espérance de vie, vaccination, antibiotiques
- Au Maroc : transition en cours, double fardeau (maladies infectieuses encore présentes + maladies chroniques)
- ⚠ Ce n'est PAS « augmentation des deux » (piège fréquent)
- ⚠ Ce n'est PAS « diminution des deux »
- ⚠ C'est diminution infectieuses + AUGMENTATION chroniques

Les transitions impactant le Maroc (et les systèmes de santé) :

- Transition DÉMOGRAPHIQUE (vieillissement, baisse fécondité)
- Transition ÉPIDÉMIOLOGIQUE (changement profil des maladies)
- Transition NUTRITIONNELLE (sous-nutrition → surnutrition / obésité)
- Transition SOCIALE / urbaine
- ⚠ Les DEUX transitions qui impactent le PLUS l'utilisation des services de santé = DÉMOGRAPHIQUE + ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Effets sur la santé (rappel transversal avec santé environnementale) :

- Effet AIGU vs CHRONIQUE
- Effet RETARDÉ (cancers post-exposition)
- Effet INFRACLINIQUE (modifications biologiques asymptomatiques)
- ⚠ Un effet peut être à la fois CHRONIQUE et RETARDÉ (ex. cancer, fibrose)

[RANG 11] MESURE DE FRÉQUENCE EN ÉPIDÉMIOLOGIE

Pr. Amine • ~0.45 Q/examen (0.9% de l'examen)

📖 Indicateurs épidémiologiques fondamentaux – Incidence, prévalence, mortalité

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Incidence vs Prévalence :

- INCIDENCE = nouveaux cas survenant pendant une période donnée
- Incidence CUMULÉE = nouveaux cas / personnes à risque au début de la période
- Densité d'INCIDENCE = nouveaux cas / personnes-temps de suivi (= TAUX)
- PRÉVALENCE = tous les cas (anciens + nouveaux) à un INSTANT donné
- Prévalence ponctuelle ≠ prévalence de période
- ⚠ La prévalence n'est PAS « le nombre de nouveaux cas » (= incidence)
- ⚠ Incidence est un TAUX (avec dénominateur personnes-temps)
- ⚠ Prévalence est une PROPORTION (sans dimension temporelle au numérateur)

Taux brut de mortalité (TBM) :

- TBM = (nombre de décès durant une période) / (effectif moyen de la population durant la même période)
- Exprimé pour 1 000 ou 100 000 habitants
- Indicateur GLOBAL de mortalité (toutes causes confondues)
- ⚠ Le TBM N'EST PAS spécifique d'une cause (= taux spécifique par cause)
- ⚠ Le TBM N'EST PAS spécifique d'une tranche d'âge (= taux spécifique par âge)

- *⚠ Le dénominateur est l'effectif MOYEN, pas la population « au milieu » de la période*

Autres indicateurs de fréquence courants :

- Taux de létalité = décès dus à une maladie / cas de la maladie (gravité)
- Taux de natalité = naissances vivantes / population moyenne
- Taux de mortalité infantile (TMI) = décès < 1 an / naissances vivantes
- Taux de fécondité = naissances vivantes / femmes en âge de procréer
- *⚠ Létalité ≠ mortalité (létalité = parmi les malades ; mortalité = parmi la population générale)*

PARTIE 4 – TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER – À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé – NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK – BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~8.7% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

Topics hors programme 2026 (par fréquence décroissante) :

Topic (hors programme)	Total	Moy/exam
Questions inclassifiables / transversales (cas cliniques)	47 Q	4.27

[HORS 1] QUESTIONS INCLASSIFIABLES / TRANSVERSALES

47 questions – 4.27 Q/examen – Questions cross-cutting (cas cliniques, calculs)

Nature des questions inclassifiables dans la banque :

- La plupart sont des sous-questions de CAS CLINIQUES intégrés (énoncé global avec plusieurs questions enchaînées)
- Couvrent des notions transversales : séquence temporelle exposition-maladie, calculs de proportions, application aux situations
- Plusieurs touchent les leçons « Initiation à la méthodologie », « Critères de causalité », « Validité d'un test diagnostic » qui n'ont pas leur tag dédié dans la banque
- ⚠ Ce ne sont PAS des cours annulés – les notions sous-jacentes SONT au programme 2026
- ⚠ Elles font partie des cas cliniques qui peuvent tomber à n'importe quel examen

Notions classiques apparaissant dans les inclassifiables :

- Distinction étude prospective / rétrospective / transversale à partir d'un cas
- Calcul de proportion (ex. % de tabagiques dans l'étude)
- Caractéristiques générales de la SP : rôle prévention + responsabilité collective + action populationnelle + agir sur déterminants
- Critères de causalité de Hill (force, cohérence, temporalité, plausibilité biologique, spécificité, gradient dose-réponse, expérimentation, analogie, cohérence)
- ⚠ À RÉVISER : critères de Hill, validité d'un test diagnostic (Se/Sp/VPP/VPN), méthodologie de recherche clinique (Pr Amine – 3 parties)

Validité d'un test diagnostic (notions clés non couvertes ailleurs) :

- SENSIBILITÉ (Se) = vrais positifs / (vrais positifs + faux négatifs) = capacité à détecter les malades
- SPÉCIFICITÉ (Sp) = vrais négatifs / (vrais négatifs + faux positifs) = capacité à éviter les faux positifs chez les non-malades
- VPP = vrais positifs / (vrais positifs + faux positifs) – dépend de la PRÉVALENCE
- VPN = vrais négatifs / (vrais négatifs + faux négatifs) – dépend de la PRÉVALENCE
- ⚠ Se et Sp NE DÉPENDENT PAS de la prévalence (= propriétés du test)
- ⚠ VPP et VPN DÉPENDENT de la prévalence
- ⚠ Quand prévalence ↑ → VPP ↑ et VPN ↓

AIDE-MÉMOIRE FINAL – HIGH-YIELD CONCOURS SANTÉ PUBLIQUE

** INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES **

Incidence cumulée	Nouveaux cas / personnes à risque (sur période)
Densité d'incidence	Nouveaux cas / personnes-temps (TAUX)
Prévalence	Tous cas / population (instant) – PROPORTION
Taux brut mortalité	Décès / effectif moyen (période)
Odds ratio (OR)	Cas-témoins – pas d'incidence
Risque relatif (RR)	Cohorte / ECR – incidence exposés / non-exposés
IC 95% significatif	NE contient PAS 1 (pour OR/RR)

** TYPES D'ÉTUDES ET LEUR USAGE **

Marqueur / Critère	Indication
Étude transversale	Mesure PRÉVALENCE (un instant)
Étude cas-témoins	Maladies RARES – calcule OR
Étude de cohorte	Calcule INCIDENCE et RR – séquence temporelle
Essai clinique randomisé	Évalue EFFICACITÉ d'une intervention – niveau preuve max
Étude écologique	Compare populations entières – biais écologique
Méta-analyse / revue	Synthèse quantitative de la littérature

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS **

- ▲ Cas-témoins → calcule OR seulement (PAS RR, PAS incidence, PAS prévalence)
- ▲ Étude transversale → calcule PRÉVALENCE seulement (PAS incidence)
- ▲ Cohorte → calcule INCIDENCE + RR (PAS prévalence)
- ▲ Randomisation contrôle facteurs de confusion CONNUS ET INCONNUS
- ▲ IC 95% significatif si EXCLUT 1 (pour OR/RR), pas 0
- ▲ Promotion = bio-psycho-social + action sur déterminants (≠ prévention)
- ▲ Déficience (anatomie) ≠ Incapacité (activité) ≠ Handicap (rôle social)
- ▲ Capacité d'adaptation = modèle ÉCOLOGIQUE de la santé
- ▲ Transition épidémiologique = ↓ infectieuses + ↑ chroniques
- ▲ Critères SMART = Spécifique + Mesurable + Atteignable + Réaliste + Temps défini
- ▲ EI évitable = ERREUR médicale ; EI lié aux soins = EIAS
- ▲ RMM = analyse rétrospective d'EI graves (revue mortalité-morbidité)

- ▲ *Tétanos / paludisme / hépatite A = transmission INDIRECTE*
- ▲ *Au Maroc : assurance maladie ne couvre PAS toute la population*
- ▲ *Dépistage = prévention SECONDAIRE (pas primaire)*

**** SCHÉMAS CONCEPTUELS CLÉS ****

- Exposition → Maladie : cohorte établit la séquence temporelle (causalité chronologique)
- Charte d'Ottawa (1986) : 5 axes – politiques publiques + milieux favorables + action communautaire + aptitudes individuelles + réorientation services
- CIF (OMS) : Maladie → Déficience → Incapacité → Handicap (désavantage social)
- Pyramide niveaux de preuve : Avis expert < Cas < Transversale < Cas-témoins < Cohorte < ECR < Méta-analyse
- Modèle Wagner CCM : soins intégrés + globaux + continus pour maladies chroniques
- Niveaux prévention : Primaire (avant) → Secondaire (dépistage) → Tertiaire (séquelles)
- Critères causalité de Hill : Force + Cohérence + Temporalité + Plausibilité biologique + Spécificité + Gradient dose-réponse + Expérimentation + Analogie + Cohérence

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-7) – Version 1
Cross-match 541 QEs officielles × Cours AIO Santé Publique 2025-2026
Pr Amine, Pr Sebbani, Pr Adermouch – FMPM 2026

Améliorations Version 1 :

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang (1 → 11) – leçons officielles uniquement
- ✓ 13 topics QE consolidés en 11 leçons officielles (cas-témoins + cohorte regroupés, sécurité + qualité regroupés)
- ✓ 6 leçons officielles sans QE historique listées en Partie 1 (mentions « pas de QE »)
- ✓ Déduplication des questions répétées + FAUX explicites avec ▲
- ✓ Aide-mémoire adapté à la Santé Publique (indicateurs épidémio, types d'études, pièges méthodologiques)
- ✓ PARTIE 4 utilisée pour les questions inclassifiables (cas cliniques transversaux) avec notions Hill + validité test diagnostic